干眼患者睑缘管理：内容提取与拟定流程

2025 · 专家共识 · DOI：10.3760/cma.j.cn115989-20250712-00228

适用于已诊断干眼者的睑缘评估、物理管理与个体化综合治疗；2025版、2026刊载。不是完整干眼诊断/药物处方指南。

lid-01 版本与适用范围

《中国干眼患者睑缘管理专家共识（2025）》为2025版，实际刊载于2026年2月。面向干眼患者的睑缘评估和物理管理，并非完整干眼诊断指南。

2025版/2026刊 p105–106 / PDF1–2；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：中国干眼患者睑缘管理专家共识（2025）

lid-02 所有干眼患者均评估睑缘

对所有已诊断为干眼的患者均应完善睑缘评估和相关疾病诊断。睑缘炎、MGD、闭合不全等可诱发或加重干眼；管理是长期、持续性过程。

2025版/2026刊 p106 / PDF2；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：对所有诊断为干眼的患者均应完善睑缘评估及睑缘相关疾病诊断。

lid-03 评估顺序与可并存分型

先评估睑缘结构异常，再看急性睑板腺炎、睑板腺囊肿等后部疾病，最后评估前部睑缘。分类依次考虑脂溢性、蠕形螨、葡萄球菌性睑缘炎及MGD；可合并2种及以上。

2025版/2026刊 p106–107 / PDF2–3；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：值得注意的是，同一患者可能合并2种及以上类型的睑缘疾病（图2）。

lid-04 病史与相关药物

问不适症状及持续时间、眼热/化学烧伤和眼睑手术史；关注酒渣鼻、甲状腺疾病、特应性皮炎、银屑病、移植物抗宿主病，以及抗组胺药、抗胆碱能药、异维A酸使用。

2025版/2026刊 p107 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：全身及局部用药情况，重点关注抗组胺药、抗胆碱能药物、异维A酸等药物的使用。

lid-05 体格与眼表检查

查视力、眼压及面部皮肤；评估倒睫、内外翻、闭合不全、瞬目，前后睑缘和睫毛根部；查泪河、泪膜破裂时间、结角膜、荧光素染色及角膜上皮/基质病变。

2025版/2026刊 p107 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：视力及眼压检查。

lid-06 辅助检查优先级

优先完善眼前节照相和睑板腺红外显影，记录睑缘、结角膜及腺体萎缩。条件允许再做分泌物刮片/培养、蠕形螨检测及激光扫描共聚焦显微镜检查。

2025版/2026刊 p107 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：检查

原文锚点：建议优先完善眼前节照相及睑板腺红外显影检查，条件允许时，再进一步进行微生物学检测及激光扫描共聚焦显微镜检查。

lid-07 图2的临床线索

脂溢性：面部皮炎、睑缘油脂堆积；蠕形螨性：睫毛根部套样分泌物且螨虫检查阳性；葡萄球菌性：充血倒睫、溃疡染色及培养等；MGD：腺体萎缩/迂曲、睑酯质/量异常。

2025版/2026刊 p107 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：诊断

原文锚点：面部皮肤炎变 睑缘油脂堆积等

lid-08 诊断阈值及危险分层缺项

本共识未给出干眼的完整确诊阈值、MGD严重度量化切点、螨虫致病数量阈值或正式危险分层评分；不能自行添加分值或用单项体征确诊所有分型。

2025版/2026刊 p106–108 / PDF2–4；推荐等级：原文未明确；类别：危险分层

原文锚点：蠕形螨是眼表微生物群的构成成分之一，需将其数量控制在致病阈值以下

lid-09 按病因治疗，居家与院内配合

急性睑板腺炎和葡萄球菌性睑缘炎积极抗细菌治疗；螨虫性者除螨。轻中度睑缘炎首选居家治疗；居家效果不佳、依从性差或中重度者可配合院内治疗。

2025版/2026刊 p107–108 / PDF3–4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：对于居家治疗效果不佳、居家治疗依从性差或中重度睑缘炎患者可配合院内治疗

lid-10 睑缘清洁：溶液、频次及疗程

推荐0.01%次氯酸、睑缘清洁液/湿巾。葡萄球菌性者推荐0.01%次氯酸；脂溢性和MGD者推荐清洁液/湿巾去油脂。每日早晚各1次，持续1个月以上。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：推荐使用0.01%次氯酸、睑缘清洁液/湿巾等进行清洁。

lid-11 清洁手法与疗效观察

垂直睑缘按压、平行睑缘擦拭交替进行。比较治疗前后症状、睑缘炎症、睫毛根部鳞屑、腺口堵塞和分泌物性状，评估疗效。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：清洁手法以垂直睑缘按压、平行睑缘擦拭交替进行

lid-12 除螨：成分、频次及疗程

建议含茶树油、4-松油醇或秋葵精油等眼部湿巾擦拭睑缘，每日2次（早晚各1次），一般2~3个月，以减少复发。具体成分浓度：原文未明确。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：建议使用含茶树油、4-松油醇或秋葵精油等眼部湿巾擦拭睑缘，每日2次（早晚各1次），治疗疗程一般为2~3个月

lid-13 除螨疗效不可只看虫数

综合螨虫数量、症状、袖套状分泌物/倒睫/乱睫等睫毛异常、睑缘炎症及睑板腺异常；不应仅以螨虫减少作为唯一疗效及治疗终点指标。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：不应仅以螨虫数量减少作为唯一疗效评判指标及治疗终点指标。

lid-14 除螨研究与刺激性提示

共识引用研究：茶树油刺激性可能影响依从性；同浓度4-松油醇比茶树油更有效且刺激性小；秋葵精油、甲硝唑眼贴有除螨研究。上述为所引研究发现。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：有研究证实茶树油有除螨作用，但在实际临床应用中，茶树油类产品存在较强刺激性

lid-15 MGD热敷参数

热毛巾或一次性湿热治疗贴，温度40~45 ℃，每次10
min以上，每日至少1次，建议坚持2周以上；之后可根据自身情况调整时长和频率。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：温度控制在40~45 ℃，每次10 min以上，每日至少1次，建议坚持2周以上

lid-16 热敷与按摩安全

热敷时勿压迫眼球。热敷后可用指腹沿垂直睑缘方向轻柔按摩促进排出，注意力度；青光眼患者谨慎操作。观察症状、腺口、睑酯分泌、腺体缺失及脂质层厚度。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：热敷时注意不要压迫眼球。

lid-17 重炎症冷敷参数

冷敷适于睑缘炎症较重者：包冰毛巾或冷敷贴，约10 ℃，持续5~10
min。炎症控制后可改为热敷，或冷热敷交替。冷敷每日次数：原文未明确。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：温度在10 ℃左右，持续5~10 min。睑缘炎症控制后可改为热敷或者冷热敷交替进行。

lid-18 湿房镜

适用于包括MGD在内的多种干眼人群，通过相对密闭空间提高局部温度、减少蒸发、改善症状；日常工作生活中按需佩戴。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：湿房镜适用于包括MGD在内的多种干眼人群

lid-19 院内睑板腺按摩

不建议患者居家进行器械性睑板腺按摩。完成热敷或IPL后，表面麻醉剂1~2滴；用玻璃棒或按摩镊轻柔挤出睑酯，避免腺体损伤；建议每周1次，持续1个月以上，再个体化调整。

2025版/2026刊 p108 / PDF4；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：建议每周按摩1次，持续1个月以上，之后可根据患者情况调整治疗频率和次数。

lid-20 院内深度清洁

表麻1~2滴；电解水润湿刷头，从低转速起、与患者沟通；鼻侧到颞侧匀速移动，重复2~4次。建议每1~2周1次，直至分泌物明显减少。

2025版/2026刊 p108–109 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：建议每1~2周深度清洁1次，直至睑缘分泌物明显减少。

lid-21 深度清洁安全

同一部位停留不超过3 s，避免按压眼球和触碰角结膜；调速时刷头背离患者。操作后生理盐水清洁皮肤，再用抗生素滴眼液或眼膏涂睑缘。

2025版/2026刊 p108–109 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：同一部位停留时间不超过3 s，避免按压眼球及触碰患者角结膜。

lid-22 IPL防护与初始参数

清洁后使用遮光眼贴/眼罩；治疗上睑需内置眼盾。滤光片590 nm；原文光强度10~16 J，推荐初始12~15 J，按Fitzpatrick肤型选择并先试斑。原文单位为J。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：选择滤光片590 nm，光强度10~16 J（根据患者皮肤Fitzpatrick分型选择，推荐选择12~15 J作为初始强度）。

lid-23 IPL操作、加强及疗程

凝胶约2 mm；光斑相接、重叠不超过10%，重复2次。囊肿/睑板腺炎完成2次基础后，小光导15~20 J局部加强。建议每2~4周1次，3~5次为1疗程，严重者可多个疗程。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：建议每2~4周治疗1次，3~5次为1个疗程

lid-24 热脉动/液脉动

维持睑缘40~42 ℃并同步按摩；连接设备、自测、正确放置治疗头，实时监测，结束后查眼及皮肤。建议单次治疗为1疗程，再次治疗间隔依疗效个体化。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：确保睑缘维持在40~42 ℃这一最佳治疗温度区间

lid-25 热脉动的研究背景

原文引用研究称MGD睑酯需加热至41.5 ℃才可能顺利排出，单次热脉动可改善分泌、泪膜及症状。41.5 ℃是所引研究结果，不替代共识40~42 ℃设备控制区间。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：研究发现

原文锚点：有研究显示，MGD患者睑酯需加热至41.5 ℃才可能被顺利排出

lid-26 光热脉动复合治疗

LED波长544和860 nm，维持40~42 ℃；加热眼睑持续90 s，需延长时评估后重置；不可夹睫毛，缓增压力并根据反馈调整。建议单次治疗，再次间隔个体化。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：通过LED光源发出波长为544和860 nm的光线

lid-27 联合治疗与长期居家维持

病情复杂或单一治疗效果不佳者推荐联合治疗；接受院内物理治疗者，常规维持热敷、清洁等居家物理治疗，加强宣教并融入日常生活。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：对于病情复杂或单一治疗方式效果不佳的患者，推荐进行联合治疗。

lid-28 IPL联合按摩的顺序

推荐先完成IPL，再行睑板腺按摩；睑板腺囊肿患者按摩时避开囊肿区域，以免挤压损伤。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：禁忌

原文锚点：推荐先完成IPL治疗，后行睑板腺按摩，针对睑板腺囊肿患者按摩时可避开囊肿区域以免造成挤压损伤。

lid-29 中重度可联合IPL与热/液脉动

中重度干眼或睑缘炎可考虑两者联合：先IPL，完成后以热脉动/液脉动替代常规按摩；治疗间隔根据疗效个体化。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：建议先行IPL治疗，治疗完成后以热脉动/液脉动取代常规的睑板腺按摩。

lid-30 药物：感染或难治/全身病变

睑缘细菌感染局部用敏感抗生素，如氧氟沙星眼膏、加替沙星凝胶；难治性或合并全身病可考虑口服阿奇霉素、多西环素、四环素，密切观察不良反应。具体剂量疗程未明确。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：对于睑缘细菌感染患者，应局部使用敏感的抗生素滴眼液或眼膏，如氧氟沙星眼膏、加替沙星凝胶等。

lid-31 手术适应情形

物理治疗效果不佳的MGD可考虑睑板腺探通；眼睑缺损积极修补以恢复形态；闭合不全必要时考虑睑缘缝合或融合手术。

2025版/2026刊 p109 / PDF5；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：对于物理治疗效果不佳的MGD患者可考虑行睑板腺探通手术。

lid-32 结构异常分支的配套处理

图2：眼睑缺损可眼膏类屏障、人工泪液并手术修补；闭合不全可瞬目练习、睡眠时粘贴眼罩等，院内BCL/巩膜镜/湿房镜，人工泪液（水剂+膏剂）、病因治疗及必要时手术。

2025版/2026刊 p107 / PDF3；推荐等级：原文未明确；类别：治疗

原文锚点：眼睑缺损 眼睑闭合不全

lid-33 疗效复评及随访缺项

复评症状、睑缘、腺口、分泌物及除螨表现，依疗效调整。统一复诊间隔、量化停治阈值及正式风险分层：原文未明确。

2025版/2026刊 p108–109 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：随访

原文锚点：之后可根据患者情况调整治疗频率和次数。

lid-34 特殊人群与禁忌缺项

青光眼患者热敷后按摩需谨慎。儿童、孕哺期专门方案，各口服抗生素的禁忌、相互作用及完整IPL禁忌证清单：原文未明确，不据本共识补编。

2025版/2026刊 p108–109 / PDF4–5；推荐等级：原文未明确；类别：特殊人群

原文锚点：青光眼患者需谨慎操作。

lid-35 推荐等级与研究区分

原文以建议、推荐等文字表达，未逐条列证据等级或推荐强度分级；引述研究结果单独标记，不将其转成共识推荐。建议不具强制性。

2025版/2026刊 p108–110 / PDF4–6；推荐等级：原文未明确；类别：适用人群

原文锚点：本共识提供的建议并非强制性，与本共识不一致的做法并不意味着错误或不当。

拟定流程（整理表达）

1. 所有干眼患者：完成睑缘评估

先结构异常，再后部疾病，最后前部睑缘；分型可并存。优先照相＋腺体红外显影。按发现分别进入2、3或4。

2025版/2026刊 p106–107 / PDF2–3

2. 有结构异常 → 结构/病因处理

眼睑缺损：积极修补；闭合不全：病因治疗及必要时睑缘缝合/融合。可与其他睑缘分型并存，合并者同时按3/4处理。

2025版/2026刊 p107、109 / PDF3、5

3. 有感染线索 → 按病原体治疗

急性睑板腺炎/葡萄球菌性：抗细菌治疗。螨虫性：除螨每日2次、一般2~3个月；疗效须同时看症状、体征及虫数。

2025版/2026刊 p107–108 / PDF3–4

4. 轻中度/MGD → 居家基础管理

清洁早晚各1次、持续1个月以上；MGD热敷40~45 ℃、每次10 min以上、每日至少1次、建议2周以上。重炎症可冷敷。

2025版/2026刊 p108 / PDF4

5. 效果不佳/依从性差/中重度 → 院内

个体化选按摩、深度清洁、IPL或脉动；继续居家。联合时先IPL后按摩/热液脉动；囊肿按摩避开病灶。

2025版/2026刊 p107–109 / PDF3–5

6. 复评 → 继续、调整或升级

比较症状、睑缘、腺口及睑酯；除螨不以虫数为唯一终点。无效MGD可考虑探通。统一复诊间隔和停治阈值：原文未明确。

2025版/2026刊 p108–109 / PDF4–5

原文缺项与核对事项

版本为2025版，实际发表于《中华实验眼科杂志》2026年2月44卷2期，刊p105–111；不得把版本年误作刊载年。

原PDF字符映射损坏，重要文字与数值经中文OCR和PDF3–5页图像人工核对。原刊p105、108、109已视觉核对。

原文未列逐条证据等级、推荐强度；所有未明确等级均写“原文未明确”。

原文未给出完整干眼确诊标准、MGD严重程度量化切点、螨虫致病数阈值或正式危险分层评分。

原文未明确儿童和孕哺期专门方案，未明确口服抗生素剂量/频次/疗程和完整药物禁忌/相互作用；不得据此补开处方。

IPL光强度及局部加强能量单位原文为J，不自行改写为J/cm²；基础参数与设备适用条件须核对原设备。

41.5 ℃来自所引研究；共识设备维持区间为40~42 ℃，不将研究温度当作热敷或设备统一设定值。

居家轻柔指腹按摩与院内器械睑板腺按摩不同；原文不建议后者自行居家操作。

统一复诊间隔、量化治疗终点/停治阈值及完整IPL禁忌清单：原文未明确。正式资料保留缺项提示。

正文与图2均提供结构异常处理；流程为整理表达，并非原图2的逐框复制，分型可并存。